内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·胸膜疾病（内科含诊断+外科）

（性感认识：关注体征和检查）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

胸膜腔本身有20ml左右的液体(润滑)→液体变多→胸腔积液

一、血胸

（1）分度：少量≤0.5L、中量 0.5-1L、大量＞1L（五一）

（2）临床表现

血性的胸腔积液见于:结核、肿瘤、肺栓塞

血胸(全血积存在胸膜腔)≠血性的胸腔积液(胸腔积液伴有出血)

①胸腔积液的表现

②血容量降低的表现（面色苍白、心悸、出汗）

（3）进行性血胸

①胸腔闭式引流量每小时超过 200ml、持续 3 小时（123）

②持续脉搏加快、血压降低，或虽经补充血容量但血压仍不稳定

③血红蛋白量、红细胞计数、血细胞比容进行性降低

④引流胸腔积血的血红蛋白浓度和红细胞计数与周围血相近且迅速凝固

⑤**开胸探查** 找病因的同时还可以止血　有凝血因子

二、胸腔积液

（一）渗出性胸水 VS 漏出性胸水

复习《生理学》：组织水肿

①心衰：静脉和毛细血管的血压/静水压↑

②营养不良、肝硬化、肾病：血浆胶渗压↓蛋白质↓

③过敏、炎症（感染/烧伤等）：毛细血管通透性↑

④丝虫病、丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变：淋巴回流受阻 橡皮虫

炎症使通透性↑的原因:
内皮细胞收缩及间隙增大
内皮细胞穿胞/吞饮增强
内皮细胞损伤-速发持续
新生毛细血管内皮细胞高通透性

	渗出性胸水≈炎症	**漏出**性胸水
机制	**通透性↑**	我的心肝肾快吃药
栗子	①胸膜炎（结核、普通细菌等**感染**）、膈下炎症（膈下脓肿、**肝脓肿**、急性胰腺炎） ②**肿瘤**（间皮瘤、恶性肿瘤转移）　胸膜上的肿瘤,间皮:胸膜、腹膜、心包膜　肿瘤→组织坏死(损伤)→抗损伤(炎症) ③**风湿**性疾病（类风湿、SLE）免疫抗损伤 ④肺梗死、气胸 损伤→抗损伤→炎症 ⑤胸膜淋巴引流受阻（癌症淋巴管阻塞、发育性淋巴管引流异常）	①胸膜毛细血管**静水压/血压↑**：**右心衰、心包积液、缩窄性心包炎**、**上腔静脉或奇静脉受阻等体循环回流障碍**、血容量增加 ②**血浆胶渗压↓**：营养不良、**肝硬化、肾病**、腹膜透析、黏液性水肿等蛋白质减少　合成蛋白质↓　黏蛋白积聚到了组织间隙,没有在血浆里 ③血管**通透性↑**：药物**过敏** ④胸膜淋巴引流受阻
	恶性肿瘤所致胸腔积液有时难以准确地归属于渗出液或漏出液	

eg.肺癌导致上腔静脉阻塞综合征→胸膜血液回流障碍→漏出液
肺癌侵犯到了胸膜→胸水中出现癌细胞→渗出液